

Trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes

F. Hirot, C. Doyen, N. Godart

Resumen: La anorexia nerviosa (AN), la bulimia y la hiperfagia bulímica (HB) son los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) más frecuentes en la adolescencia. También existen formas parciales de estos trastornos, cuyas consecuencias son igualmente preocupantes. Existen formas más variadas de los TCA en la infancia, incluyendo la AN y el trastorno alimentario restrictivo/evitativo, de más reciente descripción. Se presentan aquí los elementos etiológicos y patogénicos esenciales y se resumen los datos epidemiológicos de estos trastornos. A continuación, se describen los signos clínicos que permiten establecer un diagnóstico positivo y buscar diagnósticos diferenciales. La evolución de estos trastornos está marcada por un riesgo considerable de complicaciones somáticas (agudas o crónicas) y psiquiátricas (depresión, ansiedad, riesgo significativo de suicidio). La curación es posible, pero suele producirse tras varios años de evolución. La mortalidad es alta, sobre todo en la AN. La anorexia nerviosa y la bulimia necesitan un tratamiento precoz y continuado durante varios años. Requieren una gran coordinación entre los médicos generalistas y los psiquiatras: el tratamiento de los aspectos psíquicos y somáticos son fundamentales y se refuerzan mutuamente. También es esencial involucrar a los padres en el tratamiento, en forma de una reunión conjunta con los padres y el niño o adolescente, incluso instaurando una terapia familiar.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Anorexia nerviosa; Bulimia; Etiología; Patogenia; Comorbilidad

Plan

■ Introducción	1
■ Etiología y patogenia	1
■ Epidemiología: proporción por sexos, edad de inicio, prevalencia e incidencia	2
■ Diagnóstico positivo y diferencial	2
Anorexia nerviosa	2
Bulimia	3
Hiperfagia bulímica	5
Trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos y otros trastornos alimentarios	5
■ Evolución y pronóstico	5
Evolución de la anorexia nerviosa	5
Evolución de la bulimia	6
Otros trastornos	6
■ Tratamiento	6
Tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria	6
Tratamiento de los factores individuales y familiares asociados	7
Prevención de las complicaciones somáticas	7
■ Modalidades de tratamiento	7
Evaluación clínica y pruebas complementarias	8
Atención ambulatoria	8
Hospitalización	8
Tratamientos medicamentosos	8

■ Introducción

La conducta alimentaria está condicionada sobre todo por las necesidades fisiológicas. También es el primer soporte de las rela-

ciones interpersonales. Desde la infancia hasta la edad adulta, en la vida cotidiana, las conductas alimentarias se ven afectadas de diversas maneras por los estados emocionales y relacionales. Durante la infancia o la adolescencia, la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) debe considerarse siempre como la expresión de un problema somático o de una alteración emocional y/o relacional. La anorexia nerviosa (AN) y la bulimia (o bulimia nerviosa [BN]) fueron los primeros TCA descritos en este período de la vida. Sin embargo, hay otros, marcados por un consumo excesivo, como la hiperfagia bulímica (HB) o acceso de hiperfagia, o por un carácter restrictivo, observado en particular en los jóvenes. Desde 2013, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) también describe el trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos (ARFID, *avoidant/restrictive food intake disorder*). Sea cual sea la edad y el trastorno que presente el paciente, el proceso de diagnóstico debe ir acompañado de un proceso de evaluación clínica y pruebas complementarias que permita determinar la mejor opción terapéutica.

■ Etiología y patogenia [1, 2]

La AN y la BN son dos entidades psiquiátricas cuya etiología y patogenia siguen siendo poco conocidas. Hasta la fecha, no se han identificado las causas directas de estos trastornos y se han desarrollado numerosos modelos etiológicos y patogénicos (cada corriente teórica ha creado su propio modelo). Estos modelos han dado paso a un enfoque multidimensional a través de «modelos biopsicosociales».

Según estos modelos, los TCA aparecen en personas predispuestas (debido a factores genéticos, biológicos, hereditarios o relacionados con acontecimientos vitales), con factores desencadenantes (baja autoestima, dietas, pubertad, duelo, separación

Cuadro 1.
Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 para la anorexia nerviosa.

Anorexia nerviosa
Restricción de los aportes energéticos en relación con las necesidades, lo que conduce a un peso significativamente bajo, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la etapa de desarrollo y la salud física. El peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado. Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o conducta persistente que interfiere con el aumento de peso, a pesar de que el peso es significativamente bajo. Percepción alterada del peso o de la forma del propio cuerpo, influencia excesiva del peso o de la forma del cuerpo en la autoestima, o falta de reconocimiento de la gravedad de la delgadez actual.
Especificar el tipo: – Tipo restrictivo: durante los últimos 3 meses, la persona no ha tenido accesos recurrentes de hiperfagia ni ha recurrido a vómitos inducidos o conductas purgativas (es decir, laxantes, diuréticos, enemas). Este subtipo describe situaciones en las que la pérdida de peso se consigue principalmente mediante dietas, ayuno y/o ejercicio. – Tipo hiperfágico/purgativo: durante los últimos 3 meses, el paciente ha mostrado accesos recurrentes de glotonería y/o ha recurrido a vómitos inducidos o conductas purgativas (es decir, laxantes, diuréticos, enemas).

y, de forma más específica para la AN, alto nivel de perfeccionismo, dificultades en la autonomía y en el control de la ira o, para la BN, impulsividad y potencial depresivo) y se mantienen por factores perpetuadores (desnutrición, reacción de los demás, nuevo equilibrio psíquico), creando un verdadero círculo vicioso. La implicación de cada uno de estos elementos en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos sigue siendo poco conocida.

■ Epidemiología: proporción por sexos, edad de inicio, prevalencia e incidencia

Durante mucho tiempo se ha infravalorado la prevalencia de los TCA en los varones [3], aunque el predominio de las mujeres sigue siendo claro. El riesgo relativo de la AN es de un varón por cada diez mujeres. La frecuencia de la BN en los varones parece ser mayor: la proporción por sexos varía de 1/8 a 1/3. La HB, en cambio, parece estar repartida de forma más equilibrada: los estudios publicados indican proporciones por sexos entre 1/6 y 1/2 [4].

Tanto la AN como la BN suelen comenzar después de la pubertad, entre los 15-19 años [5-7]. Parece haber una diferencia en los varones, ya que la AN suele empezar un poco antes y la BN más tarde [6, 7].

La HB parece ser poco frecuente en los adolescentes [8]. Antes de los 12 años, las formas más frecuentes de TCA son la AN y los TCA no especificados, mientras que la BN y la HB son muy poco frecuentes a esta edad [9, 10].

El ARFID afecta más a los varones y comienza antes que la AN. Es más probable que comience en niños o adolescentes jóvenes, antes de los 12 años [11, 12].

Al parecer, se ha producido un aumento de la incidencia de los TCA, aunque no está claro si esto se debe a un aumento de la frecuencia de estos trastornos o a una mejor detección [13]. La prevalencia a lo largo de la vida de la AN según el DSM-5 varía en muestras de adultos entre el 0,8-3,6% para las mujeres y es del 0,1% para los varones [14]. Alrededor del 50% de los casos de AN en la población general se produce antes de los 18 años y la incidencia aumenta con cada año de vida entre los 12-17 años [15]. Se estima que la prevalencia de la BN a lo largo de la vida en la población general es del 1-1,7%, según los criterios del DSM IV. Utilizando los criterios del DSM-5, alcanza el 2,6% en las mujeres [16, 17] y el 0,1-0,5% en los varones [14, 18]. La prevalencia de la HB a lo largo de la vida se sitúa entre el 3-3,6% para las mujeres y el 2,1% para los varones según el DSM-5 [14]. La HB es común en personas

obesas que esperan una cirugía bariátrica, con una frecuencia del 25-50% [19].
Un reciente estudio inglés sobre una amplia muestra de adolescentes de 8-17 años que consultan a los servicios de salud mental puso de manifiesto un aumento del número de solicitudes de tratamiento por AN en los grupos de edad más jóvenes [20].

■ Diagnóstico positivo y diferencial

La AN, la BN y la HB son los trastornos más descritos en las publicaciones. Aquí se presenta su semiología, así como los criterios diagnósticos de la clasificación estadounidense del DSM-5 [21], que son en líneas generales similares a los de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). En los niños, estas clasificaciones diagnósticas no siempre son apropiadas y los especialistas pueden remitirse a los criterios empíricos propuestos por los equipos con experiencia en el campo de los TCA en la infancia.

Anorexia nerviosa

En la práctica clínica, el diagnóstico de AN se basa esencialmente en la combinación de:
• una pérdida de peso significativa;
• una falsa anorexia, que de hecho es inicialmente una restricción voluntaria ligada a un deseo de adelgazar, incluso en el caso de un bajo peso, porque la persona se percibe a sí misma como demasiado gorda.

La amenorrea, primaria o secundaria, ya no forma parte de los criterios de diagnóstico porque no permite discriminar mejor entre las personas que padecen AN y otras cuyos otros síntomas son menos graves. Este síntoma parece ser un reflejo de la gravedad de la desnutrición y puede estar enmascarado por el uso de anticonceptivos orales [22].

En las personas que padecen AN se encuentran otras características en grado variable: falta de consciencia de su propia delgadez, interés exagerado por todo lo relacionado con la comida, intento de controlar el apetito, investidura de la sensación de hambre, buscada y provocada, hiperactividad física o intelectual, a veces conducta purgativa, uso excesivo de laxantes, diuréticos o supresores del apetito. En una misma persona, puede haber una evolución meramente restrictiva o una sucesión de períodos restrictivos y bulímicos.

Los criterios diagnósticos del DSM-5 para la AN se muestran en el Cuadro 1. La Haute Autorité de Santé (HAS) francesa ha publicado recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la AN y sugiere a los médicos signos sugestivos de AN (Cuadro 2).

En la adolescencia, una joven (la mayoría de las veces) acude a la consulta con al menos uno de sus padres debido a la pérdida de peso o a otro síntoma que parece aislado. La restricción alimentaria suele ser el primer signo clínico, pero con frecuencia se niega. La pérdida de peso se establece de forma rápida, respondiendo a las aspiraciones de la adolescente, que no sólo no se preocupa por ello, sino que no le parece suficiente: puede alcanzar el 30-40% del peso inicial, amenazando a veces el pronóstico vital. Cuanto más rápida es la pérdida de peso, menos se tolera en el plano somático. La AN completa se produce cuando el peso es significativamente inferior al esperado, es decir, un índice de masa corporal (IMC) inferior al esperado para la edad y el sexo.

La AN puede ser restrictiva o estar asociada a episodios de hiperfagia y/o purgas (alrededor del 50% de los casos); es frecuente el cambio de una forma a otra [23].

El miedo a engordar y el deseo de perder más peso están asociados a la restricción y al adelgazamiento. La falta de consciencia (o incluso la negación) de su delgadez por parte de estas personas refleja la magnitud del trastorno en la percepción de su imagen corporal.

Por último, las personas con AN suelen ser perfeccionistas y tienen un funcionamiento cognitivo marcado por la rigidez [2, 24] que puede estar asociado a la hiperinvestidura escolar.

Cuadro 2.

Signos sugestivos de anorexia nerviosa (de las recomendaciones de la Haute Autorité de Santé francesa para el tratamiento de la anorexia nerviosa).

En los niños (en ausencia de criterios específicos y a partir de los 8 años)	Retraso del crecimiento estatural. Cambio de rango, hacia abajo, en el seguimiento de la curva de peso corporal (curva de IMC) Náuseas o dolores abdominales repetidos
En el adolescente (además de los cambios de rango en la curva de crecimiento estatural o la curva de peso corporal)	Adolescente traído a la consulta por los padres por un problema de peso, trastorno alimentario o anorexia Adolescente con retraso de la pubertad Adolescente con amenorrea (primaria o secundaria) o ciclos irregulares (espaniomenorrea) más de 2 años después de su primera menstruación Hiperactividad física Hiperinvestidura intelectual

IMC: índice de masa corporal.

Más raramente, la AN se asocia con potomanía (ingestión de grandes cantidades de líquido) que puede provocar hiponatremia, que a su vez puede conducir a graves trastornos neurológicos, cleptomanía, en particular el robo de alimentos, y mericismo (o rumiación: regurgitación y masticación del bolo alimenticio).

Es probable que la AN masculina esté infradiagnosticada, ya que a menudo se hace hincapié en otros diagnósticos en los varones, lo que puede retrasar el tratamiento adecuado [3]. Más que la pérdida de peso, las preocupaciones corporales están relacionadas principalmente con la estatura, la forma de los músculos y las capacidades deportivas [3]. Las conductas hiperfágicas, las purgas y la actividad física inadecuada son más frecuentes que en las niñas [3]. El IMC previo al trastorno suele ser elevado (el sobrepeso también es más frecuente en los varones que en las niñas de la población general durante la infancia) [3].

La clínica de la AN en los niños es muy similar a la de los adolescentes. En este grupo de edad, el síntoma alimentario más frecuentemente observado es la evitación de la comida [9, 10]. En este período se observan dos particularidades: la intensidad de los síntomas habituales con la generalización de las conductas de evitación de alimentos y la restricción hídrica [25]. El niño sólo dice «no tener sed». El inicio puede ser menos insidioso que en la adolescencia, y debido a la baja masa grasa de los niños, el adelgazamiento puede ser rápido y el peso puede caer a un ritmo acelerado [26]. Durante el primer episodio, los niños y preadolescentes rara vez verbalizan sus preocupaciones sobre el cuerpo o el peso, pero con frecuencia presentan quejas somáticas [9, 10] como dolor abdominal o dificultad para tragar. Las preocupaciones corporales de los niños están relacionadas con la parte superior del cuerpo («no puedo tragar», «voy a vomitar»). La pérdida de peso no siempre es deseada. La restricción alimentaria suele producirse en períodos de transición, cuando los niños ingresan en la educación secundaria, cuando se mudan de casa o cuando pierden una figura de apego real o simbólica. Los niños son sensibles a la percepción de llenado gástrico y, por tanto, evitan con mucha frecuencia la ingesta de líquidos [27]. La forma restrictiva pura es la norma en esta edad temprana [26]. La elección de alimentos puede ser sorprendente en ocasiones, ya que estos niños pueden aceptar alimentos dulces o grasos, pero siempre en cantidades restringidas. Esto puede hacer que el TCA sea más difícil de percibir para los padres [25].

Las conductas alimentarias rígidas parecen ser una prerrogativa de los niños con AN, que muestran más perfeccionismo y rigidez que los jóvenes que ya han alcanzado la pubertad [26].

La hiperactividad física, cuando está presente, puede alcanzar gran intensidad [26]. La expulsión de la comida por el vómito inducido o el uso de medicamentos como los laxantes es excepcional a esta edad [9, 10, 26].

Las complicaciones psicológicas se refieren a los síntomas que se añadirán a los de la restricción alimentaria: necesidad urgente de lavarse, limpiar y ordenar; ideas tristes o incluso suicidas y baja autoestima; toma de riesgos atacando a otros o autolesionándose. Cuando el control de la comida ya no es suficiente para reducir la ansiedad, algunos niños muy angustiados agreden su cuerpo de otras maneras: los granos pueden rasarse hasta el punto de sangrar, las costras de las heridas superficiales se arrancan, el cabello se retuerce hasta que se cae. De forma paradójica, estas conductas tienen un efecto tranquilizador tanto en los niños como en los adolescentes (reducen la ansiedad).

Comorbilidades

Un estudio reciente en la población general muestra que casi el 90% de las personas con AN cumplen los criterios de diagnóstico de una comorbilidad psiquiátrica a lo largo de su vida [28]. Así, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, especialmente los trastornos obsesivos compulsivos, se encuentran a menudo entre las comorbilidades de la AN, sobre todo en sus formas graves [29, 30]. Sin embargo, el diagnóstico de las comorbilidades es difícil, ya que la desnutrición grave suele provocar síntomas psiquiátricos de ansiedad o depresión [31]. Estos síntomas, si son preexistentes o si persisten después de la renutrición, pueden indicar un trastorno comórbido que necesita un tratamiento complementario [29, 32].

Los síntomas del espectro autista también parecen ser más frecuentes, pero como las escalas utilizadas para detectarlos siguen estando mal adaptadas a las niñas, la frecuencia de los trastornos del espectro autista comórbidos con la AN sigue estando mal evaluada [33]. La ideación suicida es común en las personas con AN, sobre todo durante la transición de las formas restrictivas a las bulímicas [34].

Diagnóstico diferencial [35]

En caso de signos somáticos, se investigan todas las posibles causas de pérdida de peso a esta edad, prestando especial atención a los siguientes diagnósticos: una patología infecciosa (tuberculosis), un trastorno digestivo (acalasia, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn), un trastorno endocrino (diabetes de tipo 1, enfermedad de Addison, panhipopituitarismo). Sin embargo, dependiendo de la situación clínica, es necesario considerar un tumor intracerebral, un proceso maligno o una patología inflamatoria. Se han descrito asociaciones entre la AN y las enfermedades autoinmunitarias (enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, diabetes de tipo 1) [26].

Deben descartarse las afecciones psiquiátricas que puedan asociarse a los trastornos alimentarios y/o a la pérdida de peso, como los delirios asociados a la anorexia o la depresión con pérdida de peso.

La evaluación clínica y mediante pruebas complementarias permite descartar estos diagnósticos.

Bulimia

La BN debe considerarse cuando hay episodios repetitivos e incontrolables de hiperfagia (acceso de bulimia), que suelen ir seguidos de estrategias para evitar el aumento de peso como los vómitos, el ejercicio, los diuréticos, los laxantes o los supresores del apetito. Estos accesos pueden ser semanales, diarios o incluso varias veces al día. Con mucha frecuencia se producen a escondidas.

Clásicamente, se describen varias fases: una fase de excitación previa con una sensación de tensión desagradable, una fase de acceso de bulimia en la que la persona engulle con prisa cantidades ingentes de alimentos de composición variable, lo que le alivia de forma transitoria, una fase de cese de la ingesta provocada en la mayoría de los casos por un estado de malestar físico (cefalea, náuseas, dolor abdominal, etc.) asociado a un malestar psicológico (vergüenza, remordimientos, sensación de haber perdido el autocontrol). Estos accesos pueden ir seguidos o no de vómitos. Además de esta forma típica, puede haber bulimia sin vómitos, con otras estrategias de control de peso: el ayuno, la

hiperactividad, el deporte intensivo, los laxantes o los diuréticos se utilizan para mantener un peso normal.

Los criterios diagnósticos del DSM-5 para la BN se presentan en el Cuadro 3.

La BN suele ser ocultada por las personas que la sufren debido a la culpa y/o la vergüenza que retrasa la búsqueda de tratamiento [35]. A veces se detecta en una exploración física minuciosa por lesiones de erosión dental, agrandamiento de las glándulas parótidas o lesiones erosivas en el dorso de los dedos (signo de Russell) [36]. Puede producirse una masticación interminable e incluso mericismo. A veces son los padres los que alertan del trastorno.

Los individuos que padecen BN suelen tener un peso normal, pero algunos reúnen los criterios de insuficiencia ponderal o sobrepeso. Suelen estar muy preocupados por su peso y su forma

Cuadro 3.
Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 para la bulimia.

Bulimia nerviosa
Aparición recurrente de accesos de hiperfagia. Un episodio de hiperfagia tiene las siguientes características: – Absorción, en un período limitado (por ejemplo, menos de 2 horas), de una cantidad de alimentos muy superior a la que la mayoría de las personas consumirían en un período similar y en las mismas circunstancias – Sensación de pérdida de control sobre la conducta alimentaria durante el episodio (por ejemplo, sensación de no poder dejar de comer o de no poder controlar qué o cuánto se come) Conductas compensatorias inapropiadas y recurrentes para evitar el aumento de peso, como vómitos inducidos, uso excesivo de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, ayuno, ejercicio excesivo Tanto la hiperfagia como las conductas compensatorias inapropiadas se producen, en promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses La autoestima está demasiado influida por el peso y la forma del cuerpo El trastorno no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa

Cuadro 4.
Complicaciones específicas de los episodios de bulimia y los vómitos.

Clínica	Pruebas complementarias	Mecanismos fisiopatológicos/consecuencias somáticas
<i>Presentación general</i>		
Callos en el dorso de los dedos e hipertrofia de las glándulas parótidas Deshidratación Debilidad muscular Mal estado dental (caries, aflojamiento de dientes) Petequias en la cara, hemorragia conjuntival	Ionograma sanguíneo: hipopotasemia Alcalosis hipoclorémica (vómitos)/acidosis hiperclorémica (laxantes), hiperamilasemia Aumento de la creatinina y de la urea en la sangre, incluso insuficiencia renal funcional	Vómitos y/o restricción de la ingestión de líquidos
<i>Estado cardíaco y hemodinámico</i>		
Palpitaciones Bradicardia	Signos de hipopotasemia en el ECG Signos de pericarditis en el ECG	Vómitos, laxantes, diuréticos
<i>Trastornos digestivos</i>		
Hipertrofia parotídea Dolor faríngeo, eritema o ulceración faríngea, esofagitis, gastritis, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, úlcera esofágica, diarrea/estreñimiento Síndrome de Mallory-Weiss excepcional, acalasia, ruptura esofágica con mediastinitis (síndrome de Boerhaave), síndrome de la arteria mesentérica superior, dilatación gástrica aguda o incluso ruptura gástrica	Hiperamilasemia	Vómitos
<i>Complicaciones urológicas y nefrológicas</i>		
	Insuficiencia renal funcional Nefropatía tubulointersticial con acidosis tubular de tipo 1 en caso de hipopotasemia prolongada, insuficiencia renal terminal	Deshidratación Hipopotasemia crónica, vómitos, diuréticos
<i>Complicaciones dentales</i>		
Caries dentales, erosión del esmalte		Vómitos

ECG: electrocardiograma.

corporal, con los que casi siempre están insatisfechos y que influyen en su autoestima. Tienen un ideal de peso bajo.

En algunos pacientes con BN es frecuente la presencia de diversas conductas impulsivas, como autolesiones, compras impulsivas, cleptomanía, conductas sexuales de riesgo e intentos de suicidio [37]. Estos diversos trastornos de conducta pueden tener repercusiones graves: enfermedades de transmisión sexual, endeudamiento, compromiso del pronóstico vital.

Los signos que hay que buscar en la exploración física son los relacionados con las complicaciones de los episodios de bulimia; se detallan en el Cuadro 4. El riesgo más frecuente es la hipopotasemia resultante de los vómitos inducidos, con posibles consecuencias cardíacas [36]. Además, hay que tener en cuenta las escarificaciones, los trastornos del ciclo menstrual (amenorrea, oligoespaniomenorrea, trastornos ovulatorios [36]) y el peso, ya que es necesario buscar el bajo peso, el sobrepeso o las fluctuaciones de peso.

Comorbilidades

Existe una sobrerepresentación de comorbilidades psiquiátricas a lo largo de la vida en las personas con diagnóstico de BN, especialmente los trastornos del estado de ánimo, en particular los episodios depresivos, o los trastornos de la personalidad [28]. La comorbilidad de la BN con el abuso o la dependencia del alcohol u otras sustancias no es despreciable [28, 30].

Diagnóstico diferencial

Para confirmar el diagnóstico de BN, es bastante fácil descartar las causas de hiperfagia secundaria de origen orgánico.

Algunas hiperfagias pueden encontrarse en otros trastornos psiquiátricos (accesos maníacos, esquizofrenia, trastorno invasivo del desarrollo) y es durante la consulta psiquiátrica cuando se descarta el diagnóstico.

La consulta también ayuda a distinguir los accesos de BN del picoteo entre las comidas (ingesta repetida de alimentos sin ninguna culpa asociada ni conducta contra el aumento de peso) [38] y

Cuadro 5.
Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 para la hiperfagia bulímica.

Acceso de hiperfagia
Aparición recurrente de accesos de hiperfagia. Un episodio de hiperfagia tiene las siguientes características: – Absorción, en un período limitado (por ejemplo, menos de 2 horas), de una cantidad de alimentos muy superior a la que la mayoría de las personas consumirían en un período similar y en las mismas circunstancias – Sensación de pérdida de control sobre la conducta alimentaria durante el episodio (por ejemplo, sensación de no poder dejar de comer o de no poder controlar qué o cuánto se come) Los accesos de hiperfagia se asocian con al menos tres de las siguientes características: – Comer mucho más rápido de lo normal – Comer hasta sentir una sensación penosa de distensión abdominal – Comer grandes cantidades de comida en ausencia de una sensación física de hambre – Comer solo por la vergüenza de la cantidad de comida que se ingiere – Sentirse disgustado consigo mismo, deprimido o muy culpable después de comer Los accesos de hiperfagia provocan una gran angustia
Los accesos de hiperfagia se producen, por término medio, al menos una vez a la semana durante 3 meses
Los accesos de hiperfagia no se acompañan con regularidad de conductas compensatorias inadecuadas como en el caso de la bulimia, y no son exclusivas de la bulimia o la anorexia nerviosa.

a diferenciar los accesos de BN de la hiperfagia (comer en exceso durante las comidas, sin un carácter incontrolable e incoercible).

Hiperfagia bulímica

La HB debe considerarse cuando hay episodios repetitivos e incontrolables de hiperfagia que no van seguidos de estrategias para evitar el aumento de peso. Estos episodios pueden ser semanales, diarios o incluso pluricotidianos. Los criterios de diagnóstico de la HB se indican en el Cuadro 5. Es el TCA más frecuente en personas con sobrepeso u obesidad, de la que es un factor de riesgo [39]. La HB se asocia a menudo con síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, abuso de sustancias, autolesiones o ideación suicida [39]. Al igual que en la AN y la BN, las comorbilidades psiquiátricas son frecuentes a lo largo de la vida de las personas con HB [28].

En la exploración física se deben buscar posibles complicaciones de la obesidad, en particular la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 [19]. Al igual que en la BN, hay que buscar la existencia de escarificaciones.

Trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos y otros trastornos alimentarios

Éstos son los TCA que se observan en el grupo de edad más joven. La CIE-10 y el DSM IV no estaban bien adaptados a los TCA de la infancia porque no tenían en cuenta la expresión evolutiva de los síntomas. El equipo londinense del Great Ormond Street Hospital elaboró una clasificación de los TCA restrictivos específica para niños [40]. Describió el trastorno de evitación de la ingesta de alimentos de origen emocional, la alimentación selectiva, la restricción alimentaria, el rechazo de la comida, la disfagia funcional (o fobia a la deglución), el síndrome de rechazo generalizado y la pérdida de apetito secundaria a la depresión [40].

El DSM-5 agrupa ahora la mayor parte de estos trastornos que comienzan con mayor frecuencia en los niños bajo el diagnóstico de ARFID. Por lo tanto, el ARFID incluye a los niños con una falta de interés por la comida o una evitación sensorial de determinados alimentos que puede ser secundaria a un episodio aversivo (trastornos gastrointestinales, episodio agudo de vómitos experimentado como traumático) [41]. Se define como un trastorno de la

alimentación o de la ingesta de alimentos que se manifiesta como una incapacidad persistente para satisfacer las necesidades nutricionales y/o energéticas adecuadas, con consecuencias somáticas (en el peso y/o en el crecimiento) y/o una clara afectación del funcionamiento psicosocial (por ejemplo, deterioro de las relaciones sociales debido a la incapacidad para controlar las situaciones de las comidas en la escuela, con los amigos, con la familia) [21].

Los síntomas somáticos gastrointestinales son frecuentes en el ARFID (dolor abdominal, náuseas, etc.), así como los trastornos de ansiedad, en particular la ansiedad generalizada, y la depresión [11, 12, 41]. Las complicaciones somáticas pueden ser las mismas que las de la AN, ya que la desnutrición también puede ser marcada [11, 12, 41].

En la CIE-10 y el DSM-5 también se describen dos trastornos alimentarios específicos de la infancia: el mericismo y la pica. El mericismo es la regurgitación repetida de alimentos sin náuseas ni presencia de enfermedad gastrointestinal. La comida puede volver a ser masticada, tragada o escupida. La pica infantil es el consumo persistente de sustancias no nutritivas (tierra, trozos de pintura, etc.). Ambos trastornos se asocian con frecuencia a trastornos del desarrollo infantil (autismo o retraso mental) [40].

■ Evolución y pronóstico

Evolución de la anorexia nerviosa

La evolución de la AN es variable. Cuanto antes se inicie el tratamiento, más eficaz será. El reto es evitar las complicaciones agudas asociadas a la desnutrición y limitar los riesgos asociados a la cronificación de estos trastornos, que van acompañados de una preocupante tasa de mortalidad [42].

En una revisión de los estudios de resultados de adultos y/o adolescentes tratados como pacientes ambulatorios u hospitalizados y seguidos durante un mínimo de 4 años, los autores concluyen que el 50% se cura, el 30% tiene síntomas residuales y el 20% se cronifica [43]. El pronóstico mejora con el tiempo y alcanza el 70% de curación después de 10 años [43]; es mejor en los adolescentes [43, 44]. La curación puede tardar varios años [44]. Muchas personas sufren otros trastornos psiquiátricos que pueden aparecer tras la curación del AN (trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo o trastornos por consumo de sustancias) [28, 44] (Cuadro 6).

Las complicaciones somáticas son numerosas en la AN [45, 46]. Hay que distinguir entre las complicaciones agudas, vinculadas a la desnutrición o a las conductas asociadas (vómitos, potomanía) y que afectan a todos los sistemas, de las complicaciones a largo plazo.

En la fase aguda, la afectación cardiovascular puede alcanzar el 60% de las personas con AN [45]. También son frecuentes otros síntomas: hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia), digestivos (estreñimiento, dolor abdominal, ardor gástrico) [45], renales, anomalías metabólicas como la hipercolesterolemia (relacionada con la aceleración del metabolismo) o alteraciones del metabolismo de la glucosa [46]. También se ha observado una repercusión en las estructuras cerebrales en las pruebas de imagen morfológicas [46]. En las mujeres en edad fértil con AN, también hay complicaciones ginecológicas, con una reducción de la fertilidad, un aumento de los abortos espontáneos y un incremento de la tasa de cesáreas [46]. La mayoría de estas complicaciones se corrigen con la renutrición [45]. La amenorrea suele durar varios meses tras el restablecimiento del peso [45].

A largo plazo, las complicaciones están relacionadas principalmente con los huesos; la osteopenia, la osteoporosis y las fracturas son más frecuentes [45]. El riesgo de complicaciones óseas aumenta con el inicio precoz de la AN, la gravedad de la desnutrición y la duración de la amenorrea [45]. El retraso en el crecimiento es una complicación significativa de la AN, sobre todo si se presenta en el período prepuberal [46].

La AN es una de las enfermedades psiquiátricas con mayor tasa de mortalidad, pero ésta parece ser menor en los pacientes tratados antes de los 20 años de edad [42]. Sin embargo, es tres veces mayor que la mortalidad de la población general en los adolescentes con AN antes de los 15 años y 10 veces mayor que la de

Cuadro 6.

Criterios somáticos de hospitalización en niños y adolescentes (de las recomendaciones para el tratamiento de la anorexia nerviosa de la Haute Autorité de Santé francesa).

Anamnésticos	Pérdida rápida de peso: más de 2 kg por semana Rechazo a comer: afagia total Rechazo a la bebida Lipotimia o mareo ortostático Cansancio o incluso agotamiento mencionado por el paciente
Clínicos	IMC <14 kg/m ² a los 17 años o IMC <13,2 kg/m ² a los 15 y 16 años o IMC <12,7 kg/m ² a los 13 y 14 años Enlentecimiento del pensamiento y del lenguaje, confusión Síndrome oclusivo Bradicardia extrema: pulso <40/min a cualquier hora del día Taquicardia Presión arterial sistólica baja (<80 mmHg) PA <80/50 mmHg, hipotensión ortostática medida por un aumento de la frecuencia cardíaca >20/min o una disminución de la PA >10-20 mmHg Hipotermia <35,5 °C
Pruebas complementarias	Acetonuria (tira reactiva de orina), hipoglucemia (<0,6 g/l) Trastornos hidroelectrolíticos o metabólicos graves, en particular: hipopotasemia, hiponatremia, hipofosfatemia (umbrales no especificados en niños y adolescentes) Concentraciones elevadas de creatinina (>100 µmol/l) Citólisis (>4 × N) Neutropenia (<1.000/mm ³) Trombocitopenia (<60.000/mm ³)

IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial.

la población general antes de los 20 años [42]. Las causas de mortalidad notificadas son las consecuencias somáticas de la AN y el suicidio [42]. Los principales factores de riesgo de mortalidad son la gravedad de la desnutrición en la primera consulta y la asociación con comorbilidades psiquiátricas [42].

Evolución de la bulimia

La BN evoluciona durante varios años. La tasa de remisión completa es del 45%, la de remisión parcial del 27% y la de cronicación del 23% [47]. Existe una tasa significativa de transición a otros tipos de TCA y a otros trastornos psiquiátricos [47]. Los intentos de suicidio son más frecuentes que en la AN restrictiva [34] y las complicaciones somáticas son graves.

La BN se asocia con frecuencia, durante su evolución, a conductas impulsivas (abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, automutilación, cleptomanía), a síndromes depresivos mayores o a trastornos de la personalidad, en particular limítrofes [28, 37, 48].

Respecto a las complicaciones somáticas, el Cuadro 4 enumera las distintas complicaciones encontradas en los trastornos con vómitos (bulimia y AN con conductas bulímicas).

Otros trastornos

Dado que la HB y el ARFID se han definido recientemente, su evolución es menos conocida [26]. Sin embargo, se sabe que los trastornos que no se tratan en la infancia tienen más probabilidades de persistir en la adolescencia y en la edad adulta, a veces con otras formas de TCA.

Los trastornos alimentarios en edades tempranas podrían ser un factor de vulnerabilidad en la adolescencia [49] y existe una continuidad de la presencia de conductas de «comer poco» (niño

restrictivo o selectivo) entre los primeros años y la infancia. En estas situaciones se discute la indicación del tratamiento, ya que esta conducta disminuye en la preadolescencia o adolescencia en la mayoría de los casos [27]. Si no hay un impacto físico negativo, el control a menudo se reduce a tranquilizar a los padres, ya que la restricción y la selección pueden durar muchos años y seguir teniendo un buen pronóstico de evolución en la adolescencia [27].

La evitación de la ingesta de alimentos de origen emocional es un trastorno con mejor pronóstico que la AN, en particular en las niñas. En la mayoría de los casos de síndrome de rechazo generalizado se informa de una remisión completa, con una duración media de tratamiento intensivo de 1-2 años [27].

■ Tratamiento

La atención debe ser lo más temprana posible para evitar la cronicación de los trastornos y mejorar así el pronóstico. Debe ser multidisciplinaria, combinando la atención somática, psicológica, social y familiar. Todos estos elementos deben desarrollarse en paralelo, con una intensidad variable en función del momento evolutivo y a lo largo de varios años, teniendo en cuenta la duración de la evolución del trastorno [4]. Dependiendo de las repercusiones del TCA en el peso y/o el metabolismo, los enfoques somáticos deben combinarse con el apoyo psicológico y psicosocial. Aquí se presentan los principios terapéuticos principales, sin tener en cuenta el tipo de TCA. Cuando una especificidad terapéutica está vinculada al tipo de trastorno, se detalla.

Los objetivos del tratamiento son tres: tratar el TCA, tratar los factores individuales y familiares asociados y prevenir las complicaciones somáticas.

Tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria

Éste es el enfoque prioritario porque tiene graves consecuencias. Los TCA tienden a autoperpetuarse y reforzarse.

En el caso del AN, hay que tener en cuenta las conductas (restricción alimentaria cuantitativa y cualitativa, potomanía) y el peso, primero de forma ambulatoria y luego en hospitalización en caso de fracaso, cronicidad o riesgo vital [50, 51].

El tratamiento somático tiene como objetivo restablecer el peso y recuperar un buen estado de salud física [50, 51]. En la AN de los jóvenes, es tanto más fundamental y necesario rápidamente cuanto que es una condición indispensable para el logro del desarrollo estatural y puberal. Es importante proporcionar al niño o al adolescente información sobre la naturaleza evolutiva del peso saludable y transmitir información sobre el crecimiento para fomentar la motivación para el cambio [27].

Además, el restablecimiento del peso permite un trabajo psicológico y de elaboración eficaz [50, 51]. Aunque el crecimiento estatural es el elemento de vigilancia fundamental en estos niños, no hay que descuidar la repercusión metabólica.

Cuando la situación no es demasiado aguda, la renutrición se efectúa al principio de forma oral. Si fracasa o si hay riesgo somático, puede ser necesaria la renutrición enteral a través de una sonda nasogástrica [45]. En todos los casos, debe ser prudente y progresiva, ya que existe el riesgo de que se produzca un síndrome de renutrición inadecuada, en el que se combinan trastornos del ritmo, descompensación cardíaca, rabdomiólisis con debilidad diafragmática que puede ser responsable de una insuficiencia respiratoria, trastornos neurológicos e insuficiencia renal aguda, que puede comprometer el pronóstico vital [45].

El tratamiento nutricional de los TCA en la infancia incluye la educación terapéutica y debe proponerse a los padres y al niño [50, 51]. Prevenir el impacto negativo de la desnutrición sobre el sistema nervioso central y el crecimiento óseo y favorecer la adaptación del niño a las comidas diarias, ya sea con la familia o en los comedores escolares, son los retos de este tratamiento.

El tratamiento sintomático de la BN se centra en los episodios de bulimia y las conductas asociadas. La hospitalización se reserva para los casos más graves: formas evolutivas con «estado» bulímico o con síntomas de depresión mayor y/o riesgo de suicidio [19].

Cuadro 7.
Evaluación clínica (de las recomendaciones para el tratamiento de la anorexia nerviosa de la Haute Autorité de Santé francesa).

Evaluación clínica	
Datos de la consulta	Antecedentes de peso corporal: porcentaje de pérdida de peso, cinética y duración de la pérdida de peso (IMC mínimo, IMC máximo y peso de estabilización) Conductas alimentarias restrictivas: inicio de la restricción, tipo de restricción (cuantitativa, cualitativa) Conductas purgativas asociadas: bulimia/vómitos, uso excesivo de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, hipertrofia de las glándulas parótidas y callosidad o irritación de los dedos por los vómitos, evaluación del estado bucodental Potomanía (cuantificación del número de litros de bebida al día) Actividad física (búsqueda de hiperactividad) Conductas adictivas: alcohol, tabaco, otras sustancias (en particular medicamentos psicótropos) Patologías asociadas conocidas: diabetes, patologías tiroideas o digestivas Exploración psiquiátrica: antecedentes psiquiátricos y rasgos actuales (depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, riesgo de suicidio, automutilación y, raramente, síntomas psicóticos), antecedentes de abuso sexual, tratamientos psicótropos Evaluación del funcionamiento familiar, especialmente respecto a la alimentación, que puede contribuir a la perpetuación de los trastornos Evaluación social (con la ayuda de un trabajador social): hiperinversión escolar o laboral, desinversión en amistades o relaciones sociales, que pueden requerir cuidados específicos (reducción del horario escolar, baja laboral, atención en grupo, etc.)
Evaluación del estado nutricional y sus consecuencias	Peso, estatura, IMC, percentil de IMC para la edad y curva de crecimiento para niños y adolescentes Evaluación del estadio puberal de Tanner en adolescentes (búsqueda de retraso puberal) Temperatura corporal Exploración cardiovascular completa en busca de signos de insuficiencia cardíaca y/o trastornos del ritmo, incluyendo la medición del pulso, la presión arterial y la búsqueda de hipotensión ortostática Estado de la piel y las faneras (automutilación), edema, síndrome acral Grado de hidratación Exploración neurológica y muscular: enlentecimiento psicomotor, atrofia muscular, hipotonía axial, astenia profunda con dificultad para realizar los movimientos habituales Exploración digestiva: glándulas salivales, tracto esofagogástrico, tránsito en particular Evaluación de las ingestas (por un dietista experimentado)

IMC: índice de masa corporal.

Tratamiento de los factores individuales y familiares asociados

El tratamiento de las dificultades psicopatológicas que subyacen o complican la AN y la BN es fundamental para tener un efecto duradero en la conducta sintomática. Las psicoterapias son el medio de acción preferido en esta situación [19, 50, 51].

La piedra angular del tratamiento psicoterapéutico de los jóvenes es el enfoque familiar (terapia familiar, consultas familiares) [17, 50, 51]. Este enfoque ha demostrado su eficacia al principio para la AN en la adolescencia y después para la BN. Los jóvenes también pueden beneficiarse de las consultas individuales, en cuanto su estado nutricional lo permita. La psicoterapia cognitiva conductual también puede proponerse para la BN, la HB [19, 51] o si existe un trastorno de ansiedad comórbido como el trastorno obsesivo compulsivo o la fobia social. Es la primera indicación en caso de fobia a la deglución y parece ser interesante en el ARFID [41].

El tratamiento psicosocial debe asociarse de forma sistemática. Se debe mantener la escolaridad en el caso del tratamiento ambulatorio y las actividades extraescolares adaptadas al estado nutricional del paciente. Son útiles las actividades cuyos objetivos principales sean trabajar la imagen corporal, la autoestima, las habilidades sociales y la conducta alimentaria.

Prevención de las complicaciones somáticas

La prevención primaria es la recuperación del peso en el caso de la AN y el cese de los episodios de bulimia en el caso de la BN [45]. Sin embargo, esto puede llevar de varios meses a varios años. Por lo tanto, es esencial un seguimiento somático regular, en coordinación con el seguimiento psiquiátrico. Debe ser efectuado por profesionales que conozcan todas las complicaciones. El control dental regular es fundamental para la detección de complicaciones; también debe permitir dar recomendaciones de higiene bucodental en relación con los trastornos del joven [19, 50, 52].

Es necesario conseguir una mejora del estado ponderal, con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, y el cese de los episodios de bulimia [32, 45]. El tratamiento preventivo de la osteoporosis con

Cuadro 8.
Pruebas complementarias (de las recomendaciones para el tratamiento de la anorexia nerviosa de la Haute Autorité de Santé francesa).

Pruebas de laboratorio	Hemograma Ionograma sanguíneo Calcemia, fosfatemia, 25OH-D ₃ Evaluación de la función renal (urea, creatinina, aclaramiento de creatinina) Evaluación de la función hepática (ALAT, ASAT, FA y TP) Albúmina, prealbúmina CRP No se recomienda la determinación de TSH a menos que exista una duda diagnóstica persistente a favor del hipertiroidismo
Pruebas complementarias	Electrocardiograma: buscar QT largo (riesgo de taquicardia ventricular polimorfa), taquicardia supraventricular o ventricular, pausas sinusales, bradicardia de la unión, onda T negativa más allá de V3 y cambios en el segmento ST Densitometría ósea (tras 6 meses de amenorrea, luego cada 2 años si hay anomalías o amenorrea persistente)

ALAT: alanina aminotransferasa; ASAT: aspartato aminotransferasa; FA: fosfatasa alcalinas; TP: tiempo de protrombina; CRP: proteína C-reactiva; TSH: tirotropina.

estrogénicos anticonceptivos no ha demostrado ser beneficioso en los ensayos terapéuticos [32].

■ Modalidades de tratamiento

El tratamiento de un TCA y en particular de la AN conlleva una fase inicial de evaluación clínica y pruebas complementarias (Cuadros 7 y 8) que determinará la intensidad de las medidas que

hay que tomar según una modalidad ambulatoria o de hospitalización. Tanto si se opta por una como por otra de estas modalidades, son los enfoques psicoterapéuticos los que se recomiendan porque sólo ellos han demostrado su eficacia; los medicamentos psicótropos se reservan para indicaciones específicas y limitadas. A excepción de las urgencias somáticas o psiquiátricas, cualquier tratamiento debe iniciarse de forma ambulatoria [19, 50, 51]. Es en caso de fracaso del tratamiento o de agravación del estado físico o psíquico del paciente cuando se plantea la cuestión de la hospitalización.

Evaluación clínica y pruebas complementarias

La HAS sugiere una evaluación clínica con pruebas complementarias que tenga en cuenta al paciente, sus antecedentes y su entorno familiar, pero también las repercusiones de la desnutrición y sus consecuencias metabólicas, óseas y cardiovasculares (Cuadros 7 y 8).

En ausencia de antecedentes personales o familiares, o de signos sugestivos (retraso evidente del crecimiento o de la pubertad que requiera pruebas complementaria), la evaluación de los ejes tirótropro, gonadótropo, somatótropo o corticótropo es opcional.

Atención ambulatoria

Para cada joven, el psiquiatra evalúa las dificultades psicológicas actuales y anteriores al TCA, así como la calidad de las interacciones familiares. De forma coordinada con el psiquiatra, el médico de cabecera y/o el pediatra evalúan las consecuencias físicas de la desnutrición y los síntomas relacionados con la alimentación. El psiquiatra y el médico de cabecera deben estar en contacto regular para compartir sus evaluaciones y ajustar el plan de cuidados de forma personalizada. El médico generalista tiene un papel fundamental en el seguimiento del estado físico de estos pacientes en cuanto a la curva de peso, la curva de crecimiento y las repercusiones somáticas y de laboratorio globales de los TCA, y trata de prevenir las posibles complicaciones. Informa al paciente y a sus padres de la situación y contribuye así al establecimiento y mantenimiento de la alianza terapéutica.

En la adolescencia, siempre se recomiendan las consultas psiquiátricas individuales alternadas con las consultas en las que participan los padres y los adolescentes. La terapia familiar es el tratamiento que ha demostrado ser más eficaz [53]. Las terapias individuales varían en sus modalidades, dependiendo de la formación del terapeuta, pero también de la personalidad del adolescente y de sus preferencias personales. El uso de mediaciones artísticas como la terapia ocupacional (centrada en el dibujo, la música, etc.), las actividades sociales, los juegos o la relajación permiten al paciente entrar en contacto con otros, intercambiar, redescubrir el placer de las relaciones interpersonales, tomar consciencia de sus experiencias corporales descentrando sus preocupaciones obsesivas por la comida. Por último, el apoyo mutuo en grupos de discusión de personas con la misma patología, dirigidos por uno o varios profesionales, suele ser beneficioso. Durante la infancia, por supuesto, pero también en la adolescencia, la implicación de los padres en el cuidado es esencial y debe ser activa para ayudarles a reapropiarse o a desarrollar las habilidades educativas y relacionales necesarias para mejorar la salud del niño [53]. Es necesario poder ofrecer diferentes tipos de apoyo a estas familias, ya que cada una encontrará sus motivaciones para el cambio de manera diferente: algunas se sienten cómodas con los modelos psicoeducativos, otras se inclinan por el análisis de las dinámicas familiares o prefieren un espacio de pareja, o incluso individual para el padre y la madre [53]. Hay que invitar a los hermanos a las entrevistas familiares y prestarles atención, ya que también pueden ser movilizados por los terapeutas, haciéndose valer como recurso terapéutico al tiempo que expresan su «estilo fraternal» frente a la enfermedad dentro de la familia. Por último, la aplicación de la terapia multifamiliar, que es más reciente, es alentadora [53], en particular para las AN más graves.

A menudo se necesitan otras personas, como un dietista, un nutricionista, un endocrinólogo, un ginecólogo y un trabajador social.

En BN, la terapia cognitivo-conductual se basa en programas específicos dedicados a las conductas alimentarias inadecuadas y a las cogniciones sobre el peso y el cuerpo que se modifican mediante técnicas de autoayuda y terapia de exposición con prevención de respuesta [54]. En los adolescentes, las técnicas se adaptan al nivel de desarrollo e implican a los padres.

Las terapias cognitivo-conductuales también parecen ser eficaces en la HB [54].

Hospitalización

Las hospitalizaciones son sólo una etapa del tratamiento y forman parte de la atención ambulatoria global.

La AN a veces conduce a una caquexia que compromete el pronóstico vital y requiere el ingreso en cuidados intensivos. Lo ideal es que estos jóvenes sean ingresados en servicios psiquiátricos especializados antes de que alcancen estadios extremos de desnutrición. La falta de oferta asistencial en algunas regiones o países provoca ingresos tardíos, lo que pone en peligro el pronóstico. Además, la presencia de trastornos depresivos o de riesgo de suicidio justifica la hospitalización en un establecimiento psiquiátrico. Sin embargo, estas hospitalizaciones siguen siendo relativamente infrecuentes. Durante toda la hospitalización, los padres deben participar en los cuidados.

Las indicaciones para la hospitalización de las personas que padecen BN son: estado bulímico, depresión grave, riesgo de raptos suicidas o repercusiones físicas graves. Estas hospitalizaciones son poco frecuentes y a menudo de urgencia en los servicios médicos. Se requiere un dictamen psiquiátrico para evaluar la necesidad posterior de hospitalización psiquiátrica. Por el contrario, los pacientes hospitalizados en psiquiatría deben ser objeto de un seguimiento somático, ya que existe un fuerte vínculo entre los riesgos somáticos y el estado psiquiátrico.

Tratamientos medicamentosos

En el caso de la AN, sobre todo en la adolescencia, por lo general no se deben prescribir psicótropos a estos pacientes. Ningún tipo de psicótropo (ansiolíticos, antidepresivos, neurolepticos, hipnóticos) ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la AN propiamente dicha, y hay pocos estudios, o ninguno, en adolescentes [32].

Los medicamentos psicótropos sólo son interesantes cuando se asocian a trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos o episodios depresivos completos [32]. No deben administrarse como tratamiento de primera línea en personas muy delgadas o desnutridas: la delgadez crea estados clínicos engañosos a nivel psíquico, asociando ansiedad y síntomas depresivos. En caso de AN, sólo deben prescribirse después de la renutrición y bajo el asesoramiento de un psiquiatra familiarizado con este trastorno.

El tratamiento de la BN se distingue por la eficacia de medicamentos psicótropos específicos, como se ha demostrado en ensayos terapéuticos controlados en adultos. Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina reducen la frecuencia de los atracones y los vómitos de forma significativa [55]. Sin embargo, no se recomiendan como tratamiento de primera línea para los adolescentes, ya que hay muy pocos estudios dirigidos a este grupo de edad de forma específica [56]. También pueden estar indicados para la depresión. En los adolescentes con HB, de nuevo, la psicoterapia debería ser el tratamiento de preferencia [19, 52].

Los tricíclicos deben evitarse en estas situaciones por sus efectos secundarios cardíacos muy peligrosos en caso de desnutrición o hipopotasemia y por el perfil impulsivo de algunos pacientes (riesgo de tentativa de suicidio medicamentoso) [32]. El creciente interés por el uso de neurolepticos atípicos, opioides y antieméticos en el tratamiento de los TCA sólo es posible en la actualidad en el marco de la investigación o en casos excepcionales por equipos especializados [32].

Respecto a los medicamentos prescritos para los trastornos somáticos, deben tratarse las deficiencias de iones y vitaminas. Dado que no se ha demostrado el interés los anticonceptivos orales estroprogestágenos para el estado óseo, no deben prescribirse de forma sistemática y se ajustan a las indicaciones clásicas del uso

de anticonceptivos en la adolescencia [32]. Por supuesto, el cuadro clásico de la AN incluye la falta de interés por la sexualidad, pero esto no es constante, y la amenorrea ligada a la desnutrición no descarta la ovulación espontánea y el embarazo. Además, en el caso de las conductas impulsivas (a menudo asociadas a la bulimia), puede asociarse una sexualidad de riesgo que requiere que el paciente sea informado.

Las complicaciones óseas y de retraso del crecimiento deben ser tratadas por especialistas.

■ Bibliografía

- [1] Godart N, Duclos J, Perderau F. Etiopathogénie des troubles des conduites alimentaires. Chapitre 19. In: Manuel de psychiatrie 3^e édition. Sous la direction de J D Guelfi, F Rouillon. Elsevier Masson. Paris; 2017. p. 490-7.
- [2] Treasure J, Schmidt U. The cognitive-interpersonal maintenance model of anorexia nervosa revisited: a summary of the evidence for cognitive, socio-emotional and interpersonal predisposing and perpetuating factors. *J Eat Disord* 2013;**1**(1):13.
- [3] Jones W, Morgan J. Eating disorders in men: a review of the literature. *J Public Mental Health* 2010;**9**(2):23-31.
- [4] Steinhausen H-C. Outcome of Eating Disorders. *Child and Adolesc Psychiatry Clin N Am* 2009;**18**(1):225-42.
- [5] Smink FRE, van Hoeken D, Oldehinkel AJ, Hoek HW. Prevalence and severity of DSM-5 eating disorders in a community cohort of adolescents. *Int J Eat Disord* 2014;**47**(6):610-9.
- [6] Micali N, Hagberg KW, Petersen I, Treasure JL. The incidence of eating disorders in the UK in 2000-2009: findings from the General Practice Research Database. *BMJ Open* 2013;**3**(5):e002646.
- [7] Javaras KN, Runfola CD, Thornton LM, Agerbo E, Birgegård A, Norring C, et al. Sex and age-specific incidence of healthcare-register-recorded eating disorders in the complete swedish 1979-2001 birth cohort. *Int J Eat Disord* 2015;**48**(8):1070-81.
- [8] Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, Deitz AC, Hudson JI, Shahly V, et al. The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Biol Psychiatry* 2013;**73**(9):904-14.
- [9] Nicholls DE, Lynn R, Viner RM. Childhood eating disorders: British national surveillance study. *Br J Psychiatry* 2011;**198**(4):295-301.
- [10] Pinhas L, Morris A, Crosby RD, Katzman DK. Incidence and Age-Specific Presentation of Restrictive Eating Disorders in Children: A Canadian Paediatric Surveillance Program Study. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2011;**165**(10):895.
- [11] Fisher MM, Rosen DS, Ornstein RM, Mammel KA, Katzman DK, Rome ES, et al. Characteristics of avoidant/restrictive food intake disorder in children and adolescents: a "new disorder" in DSM-5. *J Adolesc Health* 2014;**55**(1):49-52.
- [12] Norris ML, Robinson A, Obeid N, Harrison M, Spettigue W, Henderson K. Exploring avoidant/restrictive food intake disorder in eating disordered patients: A descriptive study: Exploring Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder. *Int J Eat Disord* 2014;**47**(5):495-9.
- [13] Hoek HW. Review of the worldwide epidemiology of eating disorders. *Curr Opin Psychiatry* 2016;**29**(6):336-9.
- [14] Lindvall Dahlgren C, Wisting L, Rø Ø. Feeding and eating disorders in the DSM-5 era: a systematic review of prevalence rates in non-clinical male and female samples. *J Eat Disord* 2017;**5**(1):56.
- [15] Godart NT, Legleye S, Huas C, Coté SM, Choquet M, Falissard B, et al. Epidemiology of anorexia nervosa in a French community-based sample of 39,542 adolescents. *Open J Epidemiol* 2013;**3**(2):53-61.
- [16] Hoek HW. Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating disorders. *Curr Opin Psychiatry* 2006;**19**(4):389-94.
- [17] Swanson SA. Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents: results from the national comorbidity survey replication adolescent supplement. *Arch Gen Psychiatry* 2011;**68**(7):714.
- [18] Raevuori A, Keski-Rahkonen A, Hoek HW. A review of eating disorders in males. *Curr Opin Psychiatry* 2014;**27**(6):426-30.
- [19] Haute Autorité de Santé. *Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge [Internet]*. Paris: HAS; 201988. Disponible sur : has-sante.fr/jcms/c_985715/fr/anorexie-mentale-prise-en-charge.
- [20] Petkova H, Simic M, Nicholls D, Ford T, Prina AM, Stuart R, et al. Incidence of anorexia nervosa in young people in the UK and Ireland: a national surveillance study. *BMJ Open* 2019;**9**(10):e027339.
- [21] American Psychiatric Association. *DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition*. Washington, DC: American Psychiatric Press Inc; 2013, 1000 p.
- [22] Attia E, Roberto CA. Should amenorrhea be a diagnostic criterion for anorexia nervosa? *Int J Eat Disord* 2009;**42**(7):581-9.
- [23] Peat C, Mitchell JE, Hoek HW, Wonderlich SA. Validity and utility of subtyping anorexia nervosa. *Int J Eat Disord* 2009;**42**(7):590-4.
- [24] Jacobi C, Hayward C, de Zwaan M, Kraemer HC, Agras WS. Coming to terms with risk factors for eating disorders: application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy. *Psychol Bull* 2004;**130**(1):19-65.
- [25] Mouren M-C, Doyen C, Le Heuzey M-F, Cook-Darzens S. *Troubles du comportement alimentaire de l'enfant du nourrisson au pré-adolescent : manuel diagnostique et thérapeutique*. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2011.
- [26] Herpertz-Dahlmann B, Dahmen B. Children in need – diagnostics, epidemiology, treatment and outcome of early onset anorexia nervosa. *Nutrients* 2019;**11**(8):1932.
- [27] Ciquillon S, Doyen C. Anorexie, boulimie. Nouveaux concepts, nouvelles approches. Lavoisier. 2016. 250 p. (Les Précis. Cahiers de Sainte Anne).
- [28] Udo T, Grilo CM. Psychiatric and medical correlates of DSM-5 eating disorders in a nationally representative sample of adults in the United States. *Int J Eat Disord* 2019;**52**(1):42-50.
- [29] Godart NT, Perdereau F, Rein Z, Berthoz S, Wallier J, Jeammot P, et al. Comorbidity studies of eating disorders and mood disorders. Critical review of the literature. *J Affect Disord* 2007;**97**(1-3):37-49.
- [30] Blinder BJ, Cumella EJ, Sanathara VA. Psychiatric comorbidities of female inpatients with eating disorders. *Psychosom Med* 2006;**68**(3):454-62.
- [31] Mattar L, Godart N, Melchior JC, Falissard B, Kolta S, Ringuenet D, et al. Underweight patients with anorexia nervosa: Comparison of bioelectrical impedance analysis using five equations to dual X-ray absorptiometry. *Clin Nutr* 2011;**30**(6):746-52.
- [32] Blanchet C, Guillaume S, Bat-Pitault F, Carles M-E, Clarke J, Dodin V, et al. Medication in AN: A multidisciplinary overview of meta-analyses and systematic reviews. *J Clin Med* 2019;**8**(2):278.
- [33] Westwood H, Tchanturia K. Autism spectrum disorder in anorexia nervosa: an updated literature review. *Curr Psychiatry Rep* 2017;**19**(7):41.
- [34] Goldstein A, Gvion Y. Socio-demographic and psychological risk factors for suicidal behavior among individuals with anorexia and bulimia nervosa: A systematic review. *J Affective Disord* 2019;**245**:1149-67.
- [35] American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders. *Am J Psychiatry* 2006;**163**:4-54.
- [36] Mehler PS. Medical complications of bulimia nervosa and their treatments. *Int J Eat Disord* 2010;**44**(2):95-104.
- [37] Waxman SE. A systematic review of impulsivity in eating disorders. *Eur Eat Disord Rev* 2009;**17**(6):408-25.
- [38] Alvarenga MS, Koritar P, Pisciolaro F, Mancini M, Cordás TA, Scagliusi FB. Eating attitudes of anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder and obesity without eating disorder female patients: differences and similarities. *Physiol Behav* 2014;**131**:99-104.
- [39] Marzilli E, Cerniglia L, Cimino S. A narrative review of binge eating disorder in adolescence: prevalence, impact, and psychological treatment strategies. *Adolesc Health Med Ther* 2018;**9**:17-30.
- [40] Bryant-Waugh R, Markham L, Kreipe RE, Walsh BT. Feeding and eating disorders in childhood. *Int J Eat Disord* 2010;**43**:98-111.
- [41] Brigham KS, Manzo LD, Eddy KT, Thomas JJ. Evaluation and treatment of avoidant/restrictive food intake disorder (arfid) in adolescents. *Curr Pediatr Rep* 2018;**6**(2):107-13.
- [42] Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: a meta-analysis of 36 studies. *Arch Gen Psychiatry* 2011;**68**(7):724-31.
- [43] Steinhausen H-C. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. *Am J Psychiatry* 2002;**159**(8):1284-93.
- [44] Jagielska G, Kacperska I. Outcome, comorbidity and prognosis in anorexia nervosa. *Psychiatr Pol* 2017;**51**(2):205-18.
- [45] Gosseume C, Dicembre M, Bemer P, Melchior J-C, Hanachi M. Somatic complications and nutritional management of anorexia nervosa. *Clin Nut Exp* 2019;**28**:2-10.
- [46] Roux H, Chapelon E, Godart N. Épidémiologie de l'anorexie mentale : revue de la littérature. *L'Encéphale* 2013;**39**(2):85-93.
- [47] Steinhausen H-C, Weber S. The outcome of bulimia nervosa: Findings from one-quarter century of research. *Am J Psychiatry* 2009;**166**(12):1331-41.
- [48] Sansone RA, Levitt JL, Sansone LA. The prevalence of personality disorders among those with eating disorders. *Eat Disord* 2004;**13**(1):7-21.
- [49] Herle M, Stavola BD, Hübel C, Abdulkadir M, Ferreira DS, Loos RJE, et al. A longitudinal study of eating behaviours in childhood and later eating disorder behaviours and diagnoses. *Br J Psychiatry* 2020;**216**(2):113-9.
- [50] Haute Autorité de Santé. *Anorexie mentale : prise en charge. Recommandations pour la pratique clinique. Argumentaire [Internet]*. Paris: HAS; 2010167. Disponible sur : has-sante.fr/jcms/c_985715/fr/anorexie-mentale-prise-en-charge.

- [51] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Eating disorders: recognition and treatment. NHS England; 2017 p. 42. (NICE guidelines). Report No.: NG69. Updated: 16 December 2020.
- [52] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Eating disorders. NHS England; 2018 p. 27. Report No.: QS175. Updated: 21 September 2018.
- [53] Brockmeyer T, Friederich H-C, Schmidt U. Advances in the treatment of anorexia nervosa: a review of established and emerging interventions. *Psychol Med* 2018;**48**(8):1228–56.
- [54] Linardon J, Wade TD, de la Piedad Garcia X, Brennan L. The efficacy of cognitive-behavioral therapy for eating disorders: A systematic review and meta-analysis. *J Consult Clin Psychol* 2017;**85**(11):1080–94.
- [55] Shapiro JR, Berkman ND, Brownley KA, Sedway JA, Lohr KN, Bulik CM. Bulimia nervosa treatment: A systematic review of randomized controlled trials. *Int J Eat Disord* 2007;**40**(4):321–36.
- [56] Hail L, Le Grange D. Bulimia nervosa in adolescents: prevalence and treatment challenges. *Adolesc Health Med Ther* 2018;**9**:11–6.

Si desea saber más

Haute Autorité de santé – Anorexie mentale : prise en charge (has-sante.fr)
Haute Autorité de santé – Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge (has-sante.fr).

F. Hirot (france.hirot@fsef.net).

Service hospitalo-universitaire de santé mentale de l'adolescent et du jeune adulte (SHU-SMAJA), Fondation santé des étudiants de France, 8, rue Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris, France.

C. Doyen.

Service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France.

N. Godart.

Service hospitalo-universitaire de santé mentale de l'adolescent et du jeune adulte (SHU-SMAJA), Fondation santé des étudiants de France, 8, rue Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris, France.

Professeur des Universités, Unité de formation et de recherche des sciences de la santé Simone-Veil (UVSQ), 2, avenue de la Source-de-la-Bière, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Hirot F, Doyen C, Godart N. Trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes. EMC - Tratado de medicina 2022;26(3):1-10 [Artículo E – 8-0882].